

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Burns

معلومات الإقرار – نسخة المريض الحروق

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure is where burnt areas of tissue are removed and may be replaced with a skin graft/s taken from other areas of the body or from other donors.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic or Location Anaesthesia and Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin)
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء تتم إزالة المناطق المحروقة من الأنسجة ، وقد يتم وضع رقعة أو رقعة جلدية بدلاً منها . هذه الرقعة قد تؤخذ من مواقع أخرى من جلد نفس المريض أو من متبرع آخر .

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقدم لك أو التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج .
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل وارفرين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابايردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر .
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية .
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Blood loss may be considerable during and after the procedure and this may mean intravenous fluid replacement or a blood transfusion.
- Debridement of the burnt tissue may cause an infection to get into the blood stream and cause serious toxic effects.
- If the burn needs a skin graft:
 - The graft may not take.
 - The graft may not look like normal tissue for some time.
 - The colour of the graft may be different from other parts of the skin.
- The donor site of the graft:
 - May discharge fluid into the dressings for some time. This fluid may need to be drained away.
 - The healing may be slow.
 - The final healed area may be thickened or discoloured or painful.
- With or without grafting, the burn areas may heal with thickening of the tissues and sometimes this may cause contraction of the tissues, resulting in difficulty in movements of the burnt area.

Notes to talk to my doctor about:

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يحدث فقدان لكمية معتبرة من الدم أثناء وبعد الإجراء ، مما يعني ضرورة تعويض الفاقد عن طريق المحاليل الوريدية أو نقل الدم.
 - تنظيف وإزالة الأنسجة المحروقة قد تسبب دخول العدوى إلى مجرى الدم مسببة تأثيرات سميّة شديدة.
 - إذا كان الحرق يحتاج لترقيع بالجلد:
 - قد يرفض الجسم الرقعة.
 - قد لا يكون مظهر الرقعة مشابه للجلد الأصلي لفترة من الوقت.
 - قد يكون لون الرقعة الجلدية مغايراً للون باقي الجلد.
 - المنطقة التي أخذت منها رقعة الجلد:
 - قد تفرز سوائل في الغيارات لفترة من الوقت. قد يتطلب الأمر تصريف وسحب هذه السوائل.
 - قد يكون الالتئام بطيئاً.
 - المنطقة التي حدث لها الالتئام النهائي قد تكون سميكة أو ذات لون مختلف أو تكون مؤلمة.
 - سواء وضعت رقعة جلدية أم لم توضع ، فإن الأجزاء المحروقة قد تلتئم بأنسجة سميكة ، وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى تقلص الأنسجة مسبباً صعوبة في حركة المنطقة المحروقة.
- أمور أتناقش حولها مع طبيبي:**
